

Plan de acción en salud ambiental y seguridad sanitaria

Breve descripción:

El componente aborda la planificación y ejecución de acciones en salud ambiental y seguridad sanitaria, integrando la estructura del sistema de salud pública, la promoción de entornos saludables y el diseño de planes de acción. Su propósito es fortalecer capacidades locales y garantizar la protección de la salud colectiva frente a riesgos ambientales.

Septiembre 2025

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Estructura y capacidades del sistema de salud pública	7
1.1. Organización del sistema de salud pública	8
1.2. Capacidades locales en salud pública	9
1.3. Articulación institucional en salud pública	10
1.4. Normatividad aplicable a la salud pública	12
2. Estrategias para la promoción de la salud ambiental	14
2.1. Diseño de estrategias educativas comunitarias.....	14
2.2. Organización de campañas de salud ambiental	18
2.3. Coordinación de acciones intersectoriales.....	21
2.4. Aplicación normativa en la promoción de entornos saludables	25
3. Diseño del plan de acción en salud ambiental y sanitaria	27
3.1. Definición de objetivos y metas	27
3.2. Identificación de actividades de manejo del riesgo ambiental.....	30
3.3. Asignación de responsables y recursos	33
3.4. Elaboración del cronograma y estrategia de seguimiento.....	35
3.5. Integración del plan según valoración de riesgos, capacidades locales y normativa	38

Síntesis	41
Material Complementario	43
Glosario	44
Referencias bibliográficas	46
Créditos	49

Introducción

La salud pública y la salud ambiental son pilares para el bienestar de cualquier comunidad. Comprender cómo se organiza el sistema, qué capacidades tiene y de qué manera se articulan las instituciones permite actuar con mayor eficacia frente a los desafíos que afectan nuestro entorno y nuestra salud.

Este contenido ofrece herramientas para diseñar estrategias y planes de acción que respondan a riesgos reales, integrando educación comunitaria, campañas, coordinación intersectorial y el cumplimiento de la normativa vigente.

A través de ejemplos prácticos y un enfoque paso a paso, se aprenderá a pasar de la teoría a la acción, con el propósito de promover entornos saludables y mejorar la calidad de vida en el territorio. Para comprender la importancia del contenido y los temas abordados, se recomienda acceder al siguiente video:

Video 1. Plan de acción en salud ambiental y seguridad sanitaria



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video: Plan de acción en salud ambiental y seguridad sanitaria

La salud de una comunidad no depende únicamente de la atención médica. También está determinada por el entorno en el que las personas viven, estudian y trabajan. Por eso, el sistema de salud pública se organiza para prevenir enfermedades, promover hábitos saludables y responder ante emergencias sanitarias.

En este contexto, las capacidades locales juegan un papel decisivo. Contar con personal capacitado, infraestructura adecuada, equipos, insumos y una buena gestión de la información marca la diferencia entre una respuesta lenta y una acción oportuna.

Pero la salud no es tarea de un solo sector. La articulación institucional permite que entidades de salud, educación, ambiente y servicios públicos trabajen juntas. Así, se optimizan recursos y se logran resultados sostenibles.

Para promover entornos saludables, se diseñan estrategias educativas, campañas comunitarias y acciones intersectoriales. Estas iniciativas, respaldadas por la normativa vigente, abordan problemas como la calidad del agua, el manejo de residuos y el control de vectores.

El diseño de un plan de acción en salud ambiental y sanitaria requiere definir objetivos claros, establecer metas medibles, identificar actividades, asignar responsables y recursos, y elaborar un cronograma con mecanismos de seguimiento.

Finalmente, todos estos elementos se integran para garantizar coherencia y viabilidad.

De esta manera, la salud pública y la salud ambiental se convierten en un esfuerzo colectivo, donde cada acción suma para proteger la vida y mejorar la calidad de los entornos en los que se desarrolla la vida comunitaria.

1. Estructura y capacidades del sistema de salud pública

El sistema de salud pública en Colombia está conformado por un conjunto de instituciones, normas, recursos y procesos orientados a proteger y mejorar la salud de la población, prevenir enfermedades y promover entornos saludables. Su estructura se fundamenta en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), regulado principalmente por la Ley 100 de 1993, la Ley 1438 de 2011 y otras disposiciones complementarias que garantizan el acceso equitativo a los servicios de salud y la vigilancia sanitaria.

Este sistema se organiza a partir de un enfoque descentralizado, en el que el Ministerio de Salud y Protección Social ejerce la dirección y formulación de políticas, mientras que los departamentos, distritos y municipios tienen responsabilidades específicas en la ejecución y control de acciones de salud pública.

Las capacidades del sistema incluyen la existencia de redes de vigilancia epidemiológica, infraestructura sanitaria, personal capacitado, planes de respuesta ante emergencias y mecanismos de articulación interinstitucional. Estas capacidades permiten desarrollar intervenciones de prevención, control y mitigación de riesgos en salud ambiental y seguridad sanitaria, priorizando la protección de las comunidades más vulnerables.

En el ámbito de la salud ambiental, el sistema se apoya en entidades como el Instituto Nacional de Salud (INS), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y las autoridades ambientales regionales, que contribuyen con datos, análisis y acciones de control. De esta manera, la estructura y capacidades de la salud pública se articulan para responder de forma efectiva a las necesidades del territorio, fortaleciendo la gestión integral del riesgo y la seguridad sanitaria.

1.1. Organización del sistema de salud pública

La salud pública en Colombia se orienta bajo un enfoque de derecho, equidad, determinación social y acción intersectorial. Esta visión se materializa mediante una estructura organizacional que involucra diferentes niveles del Estado (nacional, departamental, distrital y municipal), entidades técnicas y científicas, así como actores comunitarios e institucionales. Su objetivo es prevenir, mitigar y controlar los riesgos que afectan la salud colectiva.

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) se compone de dos grandes componentes:

- ✓ Atención individual.
- ✓ Salud pública colectiva.

Este último es liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social, que ejerce la rectoría nacional definiendo políticas, normas y directrices, y coordinando la implementación del Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) como marco programático.

La salud pública colectiva se articula con los planes de desarrollo territoriales a través de las Secretarías de Salud Departamentales, Distritales y Municipales, responsables de la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la vigilancia epidemiológica, la gestión del riesgo y el control de factores ambientales y sociales. Sin embargo, las capacidades de estas entidades varían según el territorio, lo que genera desigualdades en la respuesta frente a eventos ambientales o sanitarios.

En el ámbito técnico, el Instituto Nacional de Salud (INS) actúa como ente asesor, operativo y científico, apoyando procesos de vigilancia, investigación y respuesta a emergencias. Asimismo, instancias como los Comités de Salud Ambiental (CISA) permiten

coordinar acciones intersectoriales entre salud, ambiente, educación, planeación y otros sectores, bajo los principios de la Atención Primaria en Salud (APS).

Las capacidades locales en salud ambiental incluyen:

- ✓ **Talento humano:** profesionales en salud pública, médicos, ingenieros sanitarios, trabajadores sociales, promotores comunitarios, entre otros.
- ✓ **Recursos técnicos:** equipos de monitoreo, insumos de vigilancia, transporte, materiales educativos y de comunicación.
- ✓ **Información estratégica:** datos de morbilidad, factores de riesgo, indicadores territoriales, diagnósticos y sistemas como SIVIGILA, RUAF, SNGRD e IDEAM.
- ✓ **Infraestructura física:** laboratorios, unidades móviles, centros de salud y oficinas locales con capacidad operativa.
- ✓ **Articulación institucional:** coordinación con autoridades ambientales (CAR), entes educativos, empresas de servicios públicos, alcaldías y organizaciones comunitarias.

Identificar y fortalecer estas capacidades es clave para una planificación efectiva en salud ambiental, asegurando que las intervenciones respondan a las realidades locales y favorezcan la prevención, la respuesta oportuna y la construcción de entornos saludables de forma sostenible.

1.2. Capacidades locales en salud pública

Las capacidades locales en salud pública hacen referencia al conjunto de recursos humanos, técnicos, financieros y logísticos disponibles en un territorio para responder de manera efectiva a las necesidades y retos sanitarios. Estas capacidades determinan la

eficiencia con la que se implementan programas de prevención, vigilancia epidemiológica, promoción de la salud y atención de emergencias.

En el contexto colombiano, las entidades territoriales como alcaldías, gobernaciones y direcciones territoriales de salud, son responsables de fortalecer sus capacidades institucionales mediante la formación continua del personal, la adquisición de equipos e insumos, el uso de tecnologías de información para la gestión de datos y la coordinación intersectorial (Ministerio de Salud y Protección Social, 2022).

La evaluación de estas capacidades considera factores como la infraestructura física, la cobertura de servicios, la disponibilidad de personal especializado, la articulación con la comunidad y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Por ejemplo, en 2023 el 78 % de los municipios contaba con un plan de contingencia en salud pública, pero solo el 55 % disponía de laboratorios locales para análisis de agua y alimentos (INS, 2023).

El fortalecimiento de las capacidades locales no depende únicamente de los recursos, sino también de la planificación estratégica, el liderazgo institucional y la participación comunitaria. Estos elementos son esenciales para garantizar una respuesta oportuna y eficaz frente a los desafíos sanitarios, especialmente en territorios con alta dispersión poblacional o limitada conectividad (OPS, 2024).

1.3. Articulación institucional en salud pública

La articulación institucional en salud pública consiste en la coordinación efectiva entre entidades de distintos niveles de gobierno, sectores y disciplinas para garantizar acciones integrales que protejan y mejoren la salud de la población. Esta colaboración es fundamental para enfrentar problemáticas sanitarias complejas, que requieren

respuestas conjuntas y complementarias (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2023).

En Colombia, el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y el Sistema Nacional de Salud Pública funcionan de manera articulada con otros sistemas, como el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y el Sistema Nacional Ambiental (SINA), con el fin de atender emergencias, prevenir riesgos y promover entornos saludables (Ministerio de Salud y Protección Social, 2022).

A nivel territorial, la articulación institucional se concreta a través de:

- ✓ Comités intersectoriales de salud pública que integran autoridades de salud, educación, ambiente, planeación y servicios públicos para abordar determinantes sociales y ambientales de la salud.
- ✓ Planes de salud territorial elaborados en conjunto entre gobernaciones, alcaldías y direcciones de salud, con participación de la comunidad y otros actores clave.
- ✓ Protocolos conjuntos de respuesta frente a emergencias como brotes epidémicos, desastres naturales o contaminación ambiental.
- ✓ Convenios y alianzas estratégicas con universidades, organizaciones sociales y cooperación internacional para fortalecer capacidades técnicas y de investigación.

Según el Ministerio de Salud y Protección Social (2023), el 92 % de los departamentos colombianos reportó contar con comités intersectoriales activos, aunque en municipios de menos de 50.000 habitantes la cifra disminuye al 64 %, debido principalmente a limitaciones de personal y recursos.

El éxito de la articulación institucional está estrechamente ligado a la claridad del marco normativo, la disponibilidad de recursos y la voluntad política de los actores involucrados. Cuando las instituciones logran coordinarse de manera efectiva, se evita la duplicación de esfuerzos, se optimiza el uso de los recursos disponibles y se incrementa la capacidad de respuesta ante emergencias y necesidades de salud pública.

1.4. Normatividad aplicable a la salud pública

El marco normativo de la salud pública en Colombia establece los principios, responsabilidades y procedimientos que deben cumplir las entidades del sector para garantizar la protección, promoción y recuperación de la salud de la población. Estas normas orientan la planeación, implementación y evaluación de políticas, programas y acciones en el ámbito territorial, y aseguran que la atención sanitaria se preste bajo criterios de equidad, calidad y eficiencia.

Principales normas y disposiciones:

- ✓ **Constitución Política de Colombia (1991):** reconoce la salud como un derecho fundamental y establece la obligación del Estado de proteger la vida y garantizar condiciones que favorezcan el bienestar de la población.
- ✓ **Ley 1751 de 2015 - Ley Estatutaria de Salud:** define la salud como un derecho fundamental autónomo e irrenunciable, ordenando su garantía a través de políticas públicas integrales que incluyan acciones de prevención, protección y tratamiento.
- ✓ **Ley 9 de 1979 - Código Sanitario Nacional:** regula aspectos relacionados con saneamiento básico, control de enfermedades, inocuidad de alimentos, calidad del agua y condiciones sanitarias de los establecimientos.

- ✓ **Ley 1438 de 2011:** reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud, fortaleciendo la atención primaria en salud y el enfoque preventivo.
- ✓ **Decreto 780 de 2016 - Decreto Único Reglamentario del Sector Salud:** compila la normatividad en materia de salud, incluyendo disposiciones sobre vigilancia en salud pública, gestión del riesgo y organización de servicios.
- ✓ **Resolución 1229 de 2013:** establece lineamientos técnicos y sanitarios para actividades de inspección, vigilancia y control frente a riesgos en salud pública.
- ✓ **Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031:** define objetivos y estrategias nacionales para la protección de la salud, con especial énfasis en la promoción, prevención y control de riesgos sanitarios.

Aplicar estas disposiciones de manera efectiva garantiza que los programas y acciones en salud pública respondan a criterios técnicos, legales y éticos. Asimismo, fortalece la gobernanza sanitaria, facilita la coordinación interinstitucional y promueve entornos saludables para toda la población.

2. Estrategias para la promoción de la salud ambiental

La promoción de la salud ambiental comprende el conjunto de acciones orientadas a prevenir riesgos derivados de factores ambientales y a fomentar entornos seguros y saludables. Su implementación en el ámbito de la salud pública implica tanto intervenciones educativas y comunitarias como la coordinación intersectorial y la aplicación del marco normativo vigente.

En Colombia, estas estrategias se desarrollan bajo principios de participación comunitaria, sostenibilidad y articulación institucional, y se alinean con políticas como la Política Nacional de Educación Ambiental, el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 y los lineamientos del Sistema Nacional Ambiental (SINA).

2.1. Diseño de estrategias educativas comunitarias

Las estrategias educativas en salud ambiental son herramientas pedagógicas que buscan sensibilizar, informar y fomentar la participación social frente a los riesgos y problemáticas que vinculan el entorno con la salud humana. No se limitan a transmitir información, sino que promueven conciencia crítica, cambios de comportamiento y acción colectiva en el territorio.

En el contexto colombiano, marcado por desigualdades territoriales y socioambientales, la educación ambiental debe adaptarse a las particularidades culturales, geográficas y comunitarias de cada región, integrándose con los determinantes sociales de la salud.

Estas estrategias educativas deben orientarse hacia metas concretas que aseguren un impacto real en la comunidad y el entorno. Entre sus objetivos más relevantes se encuentran:

- ✓ Generar conciencia sobre los factores de riesgo ambiental que afectan la salud pública.
- ✓ Fortalecer competencias individuales y colectivas para identificar y prevenir dichos riesgos.
- ✓ Promover entornos saludables y sostenibles mediante participación comunitaria.
- ✓ Impulsar la corresponsabilidad intersectorial en la gestión ambiental.

Para que las estrategias educativas logren resultados sostenibles, es necesario que se fundamenten en principios que garanticen pertinencia y eficacia. Estos principios permiten que el aprendizaje sea significativo, que respete las diversidades culturales y que promueva la apropiación social del conocimiento. Entre los más relevantes se encuentran:

- a) Participación activa:** el conocimiento se construye colectivamente.
- b) Contextualización territorial:** contenidos adaptados a cultura, lengua y entorno local.
- c) Enfoque intercultural y diferencial:** reconocimiento de saberes y prácticas de comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales.
- d) Aprendizaje significativo:** ejemplos reales y cercanos para facilitar apropiación.

La educación para la salud ambiental puede implementarse a través de diversas metodologías, que van desde procesos formativos formales hasta acciones comunitarias de carácter lúdico y participativo.

Entre las más utilizadas se destacan:

- ✓ Talleres vivenciales y pedagógicos.
- ✓ Cartillas didácticas y guías comunitarias.
- ✓ Proyectos escolares ambientales (PRAE).
- ✓ Campañas comunicativas en medios locales.
- ✓ Recorridos ambientales y mapas parlantes.
- ✓ Juegos educativos y herramientas lúdicas.

Para que estas estrategias tengan continuidad y alcance, es esencial que se desarrollen en articulación con diferentes actores del territorio, integrando esfuerzos y recursos.

En este sentido, su implementación debe involucrar:

- a) Secretarías de Salud y Ambiente.
- b) Instituciones educativas y universidades.
- c) Juntas de Acción Comunal.
- d) Organizaciones sociales y ambientales.
- e) Empresas de servicios públicos.

Estas acciones se enmarcan en políticas nacionales como la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA) y el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2022-2031. Una implementación adecuada permite prevenir enfermedades, mejorar la calidad de vida y garantizar la sostenibilidad ambiental en Colombia.

A continuación, se presenta un ejemplo que describe cómo diseñar e implementar una estrategia educativa comunitaria en salud ambiental, siguiendo los principios y enfoques descritos anteriormente.

En el municipio ficticio de “San Verde”, se identificó un incremento de casos de enfermedades diarreicas agudas (EDA) asociadas al consumo de agua no tratada. A partir de un diagnóstico participativo con líderes comunitarios y la Secretaría de Salud, se diseñó la siguiente estrategia educativa:

- a) Objetivo:** capacitar a 200 familias rurales en prácticas seguras para el manejo y almacenamiento de agua, reduciendo en un 30 % los casos de EDA en seis meses.
- b) Principios aplicados:** participación activa (talleres en cada vereda), contextualización territorial (uso de ejemplos locales y lenguaje sencillo) y enfoque intercultural (integrando saberes tradicionales sobre recolección de agua de lluvia).
- c) Estrategias implementadas:**
 - ✓ Talleres vivenciales en las veredas, con demostración de sistemas de filtrado casero.
 - ✓ Distribución de cartillas ilustradas y audios radiales en la emisora comunitaria.
 - ✓ Elaboración colectiva de un “mapa parlante” de fuentes hídricas seguras y no seguras.
- d) Vinculación institucional:** participación de la Secretaría de Salud, la empresa de acueducto, el colegio rural y la Junta de Acción Comunal.

e) Evaluación: seguimiento mensual con encuestas y visitas domiciliarias para verificar cambios en las prácticas de almacenamiento de agua.

Este ejercicio demuestra cómo una estrategia educativa bien planificada integra diagnóstico, principios pedagógicos, métodos participativos y coordinación intersectorial para lograr un impacto real en la salud ambiental de una comunidad.

2.2. Organización de campañas de salud ambiental

Las campañas comunitarias en salud ambiental son intervenciones planificadas que buscan movilizar colectivamente a la población para enfrentar problemáticas ambientales que afectan la salud pública. A través de acciones pedagógicas, comunicativas y participativas, estas campañas informan, sensibilizan y promueven cambios sostenibles en el comportamiento de las personas y comunidades.

Más allá de ser eventos aislados, las campañas bien diseñadas se convierten en procesos de transformación social, ya que integran la voz de la comunidad, el trabajo intersectorial y la aplicación de enfoques educativos adaptados al territorio.

¿Qué es una campaña comunitaria en salud ambiental?

Es un conjunto de actividades organizadas y coordinadas en un tiempo determinado, con objetivos claros, que busca generar un impacto colectivo, visible y medible frente a un riesgo o desafío ambiental que incide en la salud. Una campaña efectiva combina:

- ✓ Acciones educativas para aumentar el conocimiento y la conciencia.
- ✓ Actividades movilizadoras que promueven la participación activa.

- ✓ Estrategias comunicativas que difunden mensajes claros y repetitivos.

El diseño de una campaña comunitaria en salud ambiental requiere una planificación ordenada que permita pasar de la identificación del problema a la implementación de acciones concretas y su posterior evaluación. Para lograrlo, se recomienda seguir un conjunto de fases que orienten el proceso y aseguren que las actividades sean pertinentes, participativas y sostenibles en el tiempo:

1) Diagnóstico participativo del problema

- ✓ Identificación de factores de riesgo (ej. disposición inadecuada de residuos, proliferación de vectores, consumo de agua no tratada).
- ✓ Recolección de información comunitaria y técnica.
- ✓ Priorización del problema con base en impacto y urgencia.

2) Definición de objetivos

- ✓ Deben ser específicos, medibles y alcanzables.
- ✓ Ejemplo: “Reducir la proliferación del mosquito *Aedes aegypti* en el barrio El Progreso mediante jornadas de sensibilización y recolección de inservibles durante tres meses”.

3) Segmentación de públicos

- ✓ Identificar los grupos a los que va dirigida la campaña (niños, madres, comerciantes, jóvenes).
- ✓ Adaptar mensajes y canales a las características socioculturales.

4) Diseño de mensajes y materiales

- ✓ Contenidos claros, visuales y culturalmente apropiados.
- ✓ Uso de frases cortas y orientadas a la acción: “Lava, tapa, voltea” o “No tires basura al río”.

5) Selección de medios y canales

- ✓ **Medios comunitarios:** emisoras locales, perifoneo, redes sociales.
- ✓ **Espacios físicos:** escuelas, centros de salud, parques, sedes comunales.

6) Actividades de sensibilización

- ✓ Ferias ambientales, brigadas casa a casa, murales, teatro callejero, caminatas ecológicas, concursos, trueques de residuos.

7) Articulación institucional

- ✓ Coordinación con secretarías de salud, educación y ambiente, empresas de servicios públicos y organizaciones comunitarias.

8) Evaluación y seguimiento

- ✓ Indicadores: hogares visitados, cantidad de residuos recolectados, reducción de criaderos.
- ✓ Encuestas o grupos focales antes y después de la campaña.

En diferentes regiones de Colombia, las comunidades, junto con las instituciones locales, han desarrollado campañas exitosas que integran educación, acción colectiva y creatividad para resolver problemas ambientales que afectan la salud. Algunos de estos ejemplos enseñan cómo la participación ciudadana y la articulación intersectorial logran resultados visibles y sostenibles:

- ✓ **“Hogares sin mosquito, familias sin dengue”:** lanzada en 2022 por el Ministerio de Salud y Protección Social, esta campaña con foco nacional busca involucrar a las comunidades en acciones preventivas contra el dengue en 733 municipios endémicos Ministerio de Salud.
- ✓ **“Semana de Sensibilización sobre el Mosquito”:** coordinada por la OPS, esta iniciativa anual promueve actividades educativas y de movilización

social (ferias, talleres, limpieza de criaderos, control de *Aedes aegypti*) para reducir enfermedades como dengue, chikunguña y zika Wikipedia.

- ✓ **“Basura Cero”**: recolección de residuos sólidos y sensibilización en barrios urbanos.

A continuación, se presenta un ejemplo que detalla cómo organizar una campaña comunitaria en salud ambiental:

En la vereda “La Esperanza”, los habitantes detectaron un aumento de enfermedades transmitidas por mosquitos. Se realizó un diagnóstico participativo que identificó como principal causa la acumulación de inservibles y recipientes con agua en patios y solares. Con apoyo de la Secretaría de Salud y la Junta de Acción Comunal, se diseñó la campaña “Patio Limpio, Comunidad Sana”, que incluyó:

- ✓ Jornadas de recolección de inservibles cada 15 días.
- ✓ Talleres comunitarios sobre control de vectores.
- ✓ Concurso “El patio más limpio” con premios para las familias participantes.
- ✓ Difusión de mensajes radiales y perifoneo.

Al cabo de tres meses, se observó una disminución del 40 % en la presencia de criaderos, evidenciando la efectividad de una campaña planificada con participación comunitaria e institucional.

2.3. Coordinación de acciones intersectoriales

La gestión de la salud ambiental requiere del trabajo conjunto de múltiples sectores, ya que los problemas ambientales que afectan la salud, como la contaminación del agua, la proliferación de vectores o la disposición inadecuada de residuos, son complejos y tienen causas que trascienden un único ámbito de intervención. La

coordinación intersectorial se convierte en una estrategia esencial para unir esfuerzos, optimizar recursos y lograr resultados sostenibles en el tiempo.

La intersectorialidad es un principio operativo que implica la integración de políticas, programas y recursos de distintos sectores como la salud, el ambiente, la educación, la planeación, la vivienda y los servicios públicos, con el fin de alcanzar objetivos comunes en torno a la salud y el bienestar de la población. Este trabajo no se limita a la cooperación puntual, sino que promueve la construcción colectiva de diagnósticos, planes y evaluaciones, asegurando que cada actor aporte desde sus competencias y capacidades.

En la coordinación de acciones intersectoriales, la identificación de los actores clave en el territorio es fundamental para garantizar que las intervenciones en salud ambiental sean efectivas y sostenibles. Estos actores, provenientes de distintos sectores institucionales, comunitarios y académicos, aportan conocimientos, recursos y capacidades específicas que, al integrarse, permiten abordar de manera integral los retos ambientales que afectan la salud pública.

Entre los actores más relevantes para la gestión intersectorial en salud ambiental se encuentran:

- ✓ Secretarías de Salud municipales, distritales y departamentales, responsables de liderar las acciones sanitarias, la promoción de la salud y la vigilancia epidemiológica.
- ✓ Secretarías de Ambiente y de Planeación, que orientan la gestión del territorio, el ordenamiento ambiental y la aplicación de normativas.

- ✓ Instituciones educativas, que promueven la educación ambiental mediante los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) y otras iniciativas formativas.
- ✓ Empresas de servicios públicos, fundamentales en la provisión de agua potable, el saneamiento básico y la gestión de residuos sólidos.
- ✓ Organizaciones comunitarias, como Juntas de Acción Comunal, comités ambientales o veedurías ciudadanas, que facilitan la participación directa de la comunidad.
- ✓ Organizaciones no gubernamentales (ONG) y universidades, que brindan capacidades técnicas, investigación y procesos de formación.
- ✓ Entidades del orden nacional, como el Instituto Nacional de Salud (INS), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el Ministerio de Salud y Protección Social, que aportan lineamientos técnicos, recursos y políticas.

En diferentes regiones del país, la articulación entre sectores ha dado lugar a experiencias exitosas que muestran cómo la cooperación fortalece la gestión de la salud ambiental. Estas acciones, adaptadas a las necesidades de cada territorio, integran recursos humanos, técnicos y logísticos para responder de manera conjunta a problemáticas específicas y generar impactos sostenibles en la comunidad. A continuación, se presentan algunos ejemplos representativos:

- ✓ **Mesas Territoriales de Salud Ambiental:** implementadas en departamentos como Antioquia y Cundinamarca, donde autoridades de salud, ambiente y educación, junto a líderes comunitarios, diseñan planes de acción para el

control de vectores, manejo de residuos y calidad del agua (Ministerio de Salud y Protección Social, 2022).

- ✓ **Plan Departamental de Agua y Saneamiento (PDA):** estrategia en la que participan gobernaciones, alcaldías, empresas prestadoras de servicios y comunidades para garantizar acceso a agua potable y saneamiento básico en zonas rurales (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2021).
- ✓ **Jornadas Integrales de Salud y Ambiente:** desarrolladas en zonas urbanas y rurales de Cartagena y Villavicencio, combinando vacunación, control de plagas, arborización y educación ambiental (INS, 2023).
- ✓ **Respuesta intersectorial a emergencias ambientales:** como el caso del derrame de crudo en Barrancabermeja (2018), que involucró a autoridades ambientales, sector salud, defensa civil y comunidades para la contención del impacto y atención a la población afectada (ANLA, 2019).

Para que la coordinación intersectorial en salud ambiental sea realmente exitosa, no basta con reunir a las instituciones; es necesario que exista un marco de trabajo común que oriente las relaciones, defina responsabilidades y promueva la confianza entre los actores. Estos principios funcionan como una guía práctica que facilita la planificación conjunta, fortalece la cooperación y asegura que las acciones desarrolladas sean coherentes, inclusivas y sostenibles en el tiempo. Entre los más relevantes se encuentran:

- a) **Reconocimiento de competencias:** cada sector debe actuar desde su marco normativo y experiencia.
- b) **Comunicación horizontal:** fomentar el diálogo entre iguales, evitando jerarquías innecesarias.

- c) **Planeación conjunta y seguimiento compartido:** emplear herramientas comunes como mapas, cronogramas e indicadores.
- d) **Participación comunitaria activa:** la ciudadanía no solo recibe información, sino que participa en la toma de decisiones y la ejecución de acciones.
- e) **Sostenibilidad:** asegurar que las acciones trasciendan los periodos administrativos y se mantengan en el tiempo.

Las acciones intersectoriales permiten una respuesta integral, eficiente y sostenible frente a los retos de la salud ambiental. Al articular recursos y capacidades, no solo se mejora la calidad de vida de la población, sino que se fortalece el tejido social y se generan soluciones más pertinentes y duraderas para el territorio.

2.4. Aplicación normativa en la promoción de entornos saludables

La promoción de entornos saludables en Colombia se encuentra respaldada por un marco normativo que establece lineamientos, responsabilidades y mecanismos de acción para las autoridades, las comunidades y el sector privado. Estas normas buscan garantizar condiciones ambientales adecuadas que prevengan enfermedades, fortalezcan la salud pública y promuevan el bienestar colectivo.

La aplicación efectiva de la normatividad implica no solo el conocimiento de las disposiciones legales, sino también su articulación con las políticas públicas y su adaptación a las realidades territoriales. Las autoridades locales desempeñan un papel clave al traducir las leyes en acciones concretas, fiscalizar su cumplimiento y fomentar la corresponsabilidad ciudadana.

Principales normas y políticas relacionadas con entornos saludables en Colombia:

- ✓ **Constitución Política de Colombia (1991):** reconoce el derecho a un ambiente sano (Art. 79) y el deber del Estado de protegerlo y prevenir el deterioro ambiental.
- ✓ **Ley 9 de 1979 – Código Sanitario Nacional:** regula aspectos de salubridad pública, calidad del agua, manejo de residuos, control de vectores y saneamiento básico.
- ✓ **Ley 99 de 1993:** crea el Ministerio de Ambiente y establece principios para la gestión ambiental, la participación ciudadana y la coordinación interinstitucional.
- ✓ **Ley 715 de 2001:** define competencias de los entes territoriales en salud pública y saneamiento.
- ✓ **Política Nacional de Salud Ambiental (PNSA):** orienta las acciones para prevenir y controlar riesgos ambientales que afectan la salud.
- ✓ **Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2022-2031:** integra la promoción de entornos saludables como una de sus estrategias prioritarias.
- ✓ **Decreto 780 de 2016:** compila las normas del sector salud, incluyendo disposiciones sobre vigilancia sanitaria y ambiental.

Pese a contar con un robusto marco legal, la implementación enfrenta desafíos como la limitada capacidad técnica y financiera de algunos municipios, la baja apropiación comunitaria de las normas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y sanción.

El cumplimiento de la normatividad se potencia cuando las comunidades comprenden su alcance y participan activamente en su vigilancia. Los procesos de

educación y sensibilización permiten que las disposiciones legales dejen de verse como simples obligaciones y se conviertan en herramientas para mejorar la calidad de vida y preservar el ambiente.

3. Diseño del plan de acción en salud ambiental y sanitaria

El plan de acción en salud ambiental y sanitaria es una herramienta estratégica que orienta las intervenciones para prevenir, mitigar o eliminar los riesgos que afectan la salud de la población y el equilibrio del entorno. Su diseño debe basarse en diagnósticos participativos, evidencias científicas y en el marco normativo vigente, garantizando que las acciones sean coherentes, viables y sostenibles.

Este plan no solo establece qué se va a hacer, sino también cómo, quién lo hará, con qué recursos y en qué tiempos, asegurando un seguimiento constante para evaluar resultados y realizar los ajustes necesarios.

3.1. Definición de objetivos y metas

La definición de objetivos y metas es el punto de partida para la construcción de un plan de acción en salud ambiental y sanitaria. Esta etapa orienta todas las decisiones posteriores, ya que establece qué se quiere lograr y en qué plazo.

Los objetivos representan el propósito general del plan y deben ser coherentes con las prioridades identificadas en el diagnóstico situacional. Su formulación debe responder a las siguientes características:

- ✓ **Claros y comprensibles:** que cualquier persona involucrada los entienda sin ambigüedades.
- ✓ **Realistas:** que se puedan alcanzar con los recursos y capacidades disponibles.

- ✓ **Pertinentes:** que estén alineados con la problemática identificada y con las políticas nacionales o locales de salud y ambiente.

Para que sean efectivos, los objetivos deben ser claros, medibles, alcanzables, relevantes y estar delimitados en el tiempo, siguiendo el enfoque SMART (por sus siglas en inglés):

- ✓ **Specific:** (Específico)
- ✓ **Measurable:** (Medible)
- ✓ **Achievable:** (Alcanzable)
- ✓ **Relevant:** (Relevante)
- ✓ **Time-bound:** (Tiempo definido)

Esto asegura que las acciones se realicen de manera estratégica, optimizando recursos y garantizando resultados verificables.

Además, la formulación de objetivos y metas debe responder al diagnóstico previo de riesgos ambientales, a las capacidades institucionales y comunitarias, y a la normatividad vigente. Este alineamiento permite que el plan sea coherente, factible y socialmente pertinente.

A continuación, se presenta un ejemplo de formulación de objetivos y metas para un plan de acción en salud ambiental:

Tabla 1. Formulación de objetivos y metas en el plan de acción en salud ambiental y sanitaria

Objetivo	Meta	Indicador	Plazo	Responsable
Mejorar las condiciones de saneamiento básico en la vereda San Isidro, para reducir riesgos sanitarios asociados a la disposición inadecuada de residuos.	Implementar 3 jornadas comunitarias de recolección de residuos, con participación de al menos el 70 % de los hogares.	Número de jornadas realizadas y porcentaje de participación comunitaria.	4 meses	Secretaría de Salud Municipal y Junta de Acción Comunal.
Reducir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, en el barrio El Progreso.	Disminuir en un 40 % los criaderos identificados en la inspección inicial.	Porcentaje de criaderos eliminados respecto al diagnóstico de línea base.	6 meses	Secretaría de Salud, líderes comunitarios y promotores de salud.

Objetivo	Meta	Indicador	Plazo	Responsable
Fortalecer la educación ambiental en instituciones educativas del municipio.	Implementar un programa de capacitación ambiental en el 100 % de los colegios rurales.	Número de colegios con el programa implementado.	1 año	Secretaría de Educación, Secretaría de Ambiente.

La integración de objetivos y metas claras no solo orienta las acciones del plan, sino que también facilita la rendición de cuentas, la transparencia y la sostenibilidad de los procesos.

3.2. Identificación de actividades de manejo del riesgo ambiental

La asignación de responsables y recursos es un paso fundamental para garantizar la ejecución efectiva de un plan de acción en salud ambiental. Consiste en definir claramente quién se encargará de cada actividad, qué recursos serán necesarios y de dónde provendrán, evitando duplicidades y asegurando que las tareas se cumplan en los plazos establecidos.

En este proceso es importante:

- 1) Nombrar un responsable principal para cada actividad, con autoridad y capacidad de gestión.

- 2) Identificar actores de apoyo, tanto institucionales como comunitarios, que participarán en la ejecución.
- 3) Precisar los recursos necesarios, que pueden ser financieros, materiales, humanos o técnicos.
- 4) Definir la fuente de financiación, ya sea presupuesto institucional, convenios, aportes comunitarios o cooperación externa.
- 5) Establecer plazos concretos, acordes con las prioridades y la disponibilidad de medios.

Un instrumento útil para este propósito es la matriz de asignación de responsabilidades y recursos, que permite visualizar de forma clara los compromisos y requerimientos de cada acción.

A manera de ejemplo, se presenta una matriz de asignación de responsables y recursos en un plan de acción en salud ambiental:

Tabla 2. Matriz de asignación de responsables y recursos

Actividad	Responsable principal	Actores de apoyo	Recursos necesarios	Fuente de financiación	Plazo
Jornada de eliminación de criaderos de Aedes aegypti en	Secretaría Municipal de Salud.	Juntas de Acción Comunal, Instituciones Educativas.	Bolsas para residuos, guantes, afiches informativos , vehículo	Presupuesto municipal de salud.	15 días

Actividad	Responsable principal	Actores de apoyo	Recursos necesarios	Fuente de financiación	Plazo
el barrio San José.			para recolección.		
Taller comunitario sobre manejo seguro del agua.	Empresa de Servicios Públicos.	Secretaría de Educación, líderes comunitarios .	Material didáctico, proyector, salón comunal.	Recursos propios de la empresa.	1 mes
Campaña de sensibilización sobre disposición adecuada de residuos sólidos.	Secretaría de Ambiente.	ONG ambiental, emisora comunitaria.	Afiches, perifoneo, bolsas reutilizables.	Aportes de ONG y alcaldía.	3 semanas
Siembra de árboles en zonas ribereñas	Secretaría de Planeación.	Corporación Autónoma Regional, colegios.	Plántulas, herramientas, transporte.	Convenio interinstitucional.	2 meses

Actividad	Responsable principal	Actores de apoyo	Recursos necesarios	Fuente de financiación	Plazo
para prevenir erosión.					

Esta herramienta no solo organiza la información, sino que también facilita el seguimiento, ya que permite identificar de forma rápida los responsables, los recursos asignados y el estado de ejecución de cada actividad.

3.3. Asignación de responsables y recursos

La correcta ejecución de un plan de acción en salud ambiental depende en gran medida de una adecuada asignación de responsabilidades y de los recursos necesarios para cada actividad. Este proceso garantiza que todas las acciones tengan un responsable claramente identificado, así como los insumos, el personal y el presupuesto requeridos para su desarrollo.

La asignación de responsables implica designar a las instituciones, dependencias o actores comunitarios que liderarán o apoyarán cada actividad, definiendo su rol y nivel de compromiso. Esto permite una mejor coordinación, evita la duplicación de esfuerzos y asegura que cada tarea cuente con seguimiento y evaluación oportuna.

Por su parte, la asignación de recursos contempla la identificación y gestión de los elementos materiales, financieros, tecnológicos y humanos que se requieren para el cumplimiento de las actividades. En este punto es fundamental garantizar la

disponibilidad de dichos recursos desde la planeación, para prevenir retrasos o incumplimientos.

Entre los tipos de recursos que pueden incluirse se encuentran:

- ✓ **Recursos humanos:** personal técnico, promotores de salud, líderes comunitarios y voluntarios.
- ✓ **Recursos materiales:** equipos, herramientas, insumos y materiales educativos.
- ✓ **Recursos financieros:** presupuestos asignados por entidades públicas o privadas, fondos de cooperación o donaciones.
- ✓ **Recursos logísticos y tecnológicos:** transporte, espacios físicos, plataformas de comunicación, sistemas de monitoreo y análisis de datos.

A manera de ejemplo, se presenta una matriz de asignación de responsables y recursos en un plan de acción en salud ambiental:

Tabla 3. Matriz de asignación de responsables y recursos

Actividad	Responsable principal	Apoyos institucionales	Recursos necesarios	Fuente de recursos
Jornada de recolección de inservibles para control de vectores.	Secretaría de Salud Municipal.	Juntas de Acción Comunal y Empresa de Servicios Públicos.	Volquetas, guantes, costales y material educativo.	Presupuesto municipal y donaciones de empresa privada.

Actividad	Responsable principal	Apoyos institucionales	Recursos necesarios	Fuente de recursos
Taller comunitario sobre uso seguro del agua.	Institución Educativa Rural El Progreso.	Secretaría de Ambiente y líderes comunitarios.	Material audiovisual, cartillas y refrigerios.	Fondo de proyectos ambientales escolares (PRAE).
Campaña radial sobre disposición adecuada de residuos.	Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía.	Emisora comunitaria y ONG ambiental.	Espacios radiales, cuñas y material gráfico.	Recursos de comunicación institucional.

La claridad en la asignación de responsables y recursos fortalece la ejecución del plan, ya que cada actor conoce su papel, dispone de los insumos necesarios y puede rendir cuentas sobre los avances. Además, permite que las actividades se desarrollen de manera ordenada, optimizando el uso de los recursos disponibles y favoreciendo la sostenibilidad de las acciones en el tiempo. Una distribución bien planificada es, por tanto, un elemento clave para garantizar el impacto y la eficacia de las intervenciones en salud ambiental.

3.4. Elaboración del cronograma y estrategia de seguimiento

El cronograma es una herramienta de planificación que organiza las actividades del plan de acción en el tiempo, asignando fechas de inicio y finalización para cada tarea, así

como la secuencia lógica en la que deben ejecutarse. Una buena programación permite priorizar acciones, distribuir la carga de trabajo y coordinar de forma eficiente a los distintos responsables.

La estrategia de seguimiento, por su parte, garantiza que el plan avance de acuerdo con lo establecido, identificando retrasos, dificultades o necesidades de ajuste. Este proceso implica la definición de indicadores de cumplimiento, la recolección periódica de información y la realización de reuniones de revisión para tomar decisiones oportunas.

Para que el cronograma sea efectivo, debe incluir:

- ✓ Todas las actividades definidas en el plan.
- ✓ Fechas precisas de inicio y término.
- ✓ Responsables directos de cada tarea.
- ✓ Recursos necesarios para su ejecución.
- ✓ Espacios programados para el seguimiento y la evaluación intermedia.

El seguimiento continuo no solo ayuda a cumplir con los tiempos establecidos, sino que también permite realizar mejoras durante la ejecución, evitando que los problemas se detecten únicamente al final. Así, el cronograma y el sistema de monitoreo se convierten en herramientas complementarias para garantizar la efectividad del plan de acción en salud ambiental.

A manera de ejemplo, se presenta a continuación una tabla de cronograma que integra actividades, responsables, recursos, fechas e indicadores de seguimiento:

Tabla 4. Cronograma de actividades

Actividad	Responsable principal	Recursos necesarios	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Indicador de seguimiento
Jornada de recolección de inservibles para control de Aedes aegypti.	Secretaría de Salud Municipal.	Personal técnico, vehículos, bolsas y guantes.	05/09/2025	06/09/2025	Cantidad de inservibles recolectados (kg).
Taller comunitario sobre disposición adecuada de residuos sólidos.	JAC Barrio El Progreso.	Material pedagógico , salón comunal y facilitador.	10/09/2025	10/09/2025	Número de asistentes y nivel de satisfacción.
Limpieza y desinfección de tanques de	Empresa de Servicios Públicos.	Cloro, cepillos y equipos de	15/09/2025	16/09/2025	Porcentaje de tanques intervenidos.

Actividad	Responsable principal	Recursos necesarios	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Indicador de seguimiento
almacenamiento de agua.		protección personal.			
Campaña radial “Agua Limpia, Salud Segura”.	Oficina de Comunicaciones Alcaldía.	Espacios radiales y cuñas grabadas.	20/09/2025	30/09/2025	Número de emisiones radiales.
Evaluación intermedia del plan de acción.	Comité Técnico de Salud Ambiental.	Formatos de evaluación, base de datos y reuniones.	05/10/2025	06/10/2025	Informe de avances elaborado.

Contar con un cronograma detallado y un sistema de seguimiento bien definido permite que la gestión del plan sea proactiva y no reactiva. De este modo, los ajustes se realizan sobre la marcha, se optimizan los recursos y se incrementa la probabilidad de lograr los resultados esperados en el tiempo previsto.

3.5. Integración del plan según valoración de riesgos, capacidades locales y normativa

La integración del plan de acción en salud ambiental y sanitaria es la fase en la que todos los elementos trabajados previamente, como objetivos, metas, actividades,

responsables, recursos, cronograma y mecanismos de seguimiento, se consolidan en un solo documento articulado, claro y operativo. Este proceso asegura que cada componente esté alineado con las prioridades identificadas y que exista coherencia entre lo que se plantea y lo que se puede ejecutar.

La valoración de riesgos ambientales y sanitarios es el punto de partida para priorizar las acciones. Para ello, se utilizan herramientas como matrices de riesgo, mapas comunitarios, análisis epidemiológicos y diagnósticos participativos. Estos insumos permiten definir qué problemáticas requieren atención inmediata, cuáles pueden abordarse a mediano o largo plazo y cómo se distribuyen los esfuerzos para lograr el mayor impacto posible en la salud de la población.

Asimismo, la integración del plan debe considerar las capacidades locales:

- ✓ La disponibilidad de personal técnico y comunitario.
- ✓ La infraestructura existente.
- ✓ Los recursos financieros.
- ✓ Las alianzas interinstitucionales.
- ✓ El grado de participación social.

Un plan desconectado de la realidad territorial tiende a quedarse en el papel; por ello, se recomienda ajustar las metas y actividades a lo que realmente es factible, sin perder de vista la proyección hacia mejoras sostenibles.

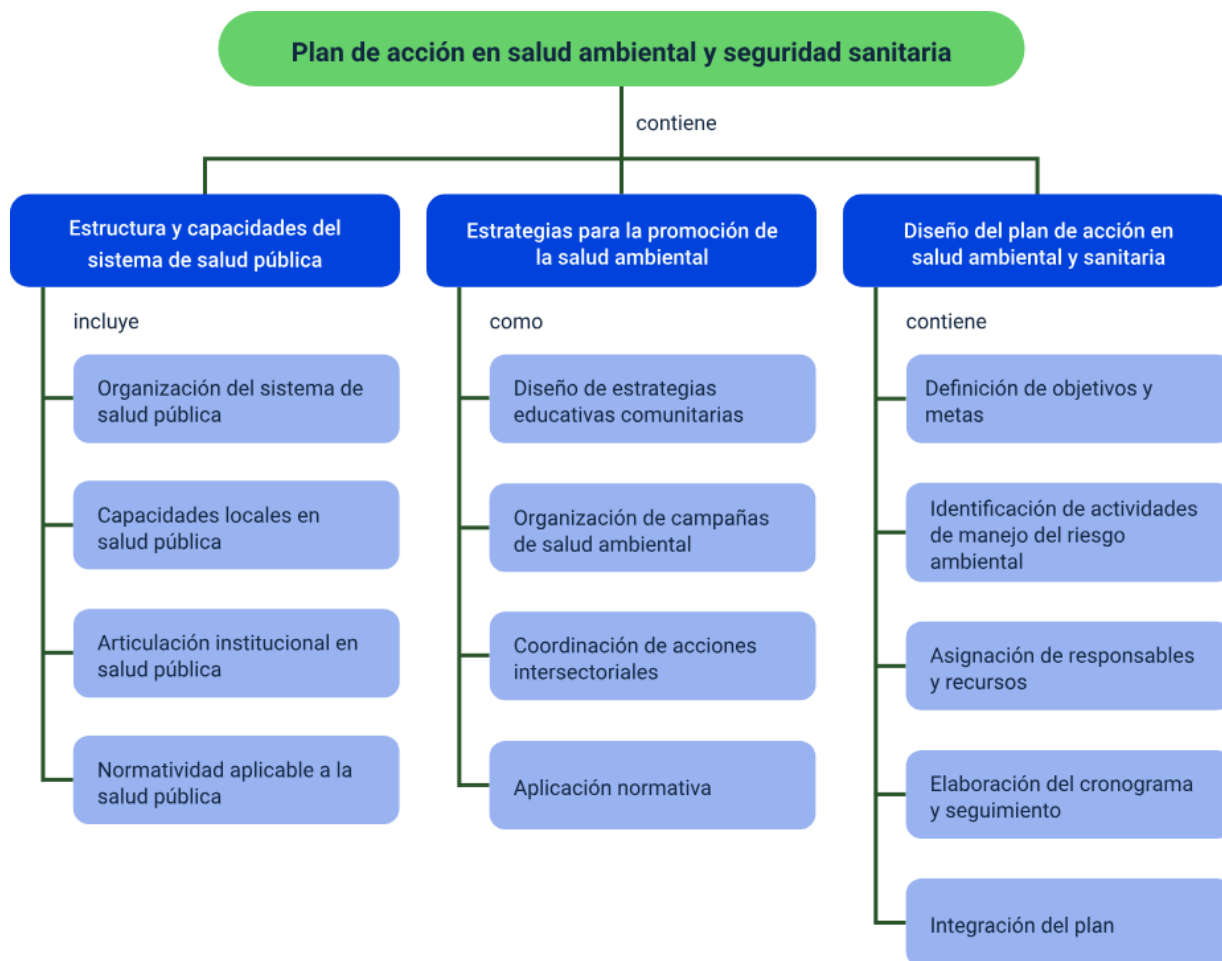
En paralelo, es indispensable garantizar que el plan se enmarque dentro de la normatividad vigente, tanto en el ámbito local como nacional. Esto incluye el cumplimiento de leyes, decretos, resoluciones y lineamientos técnicos que regulan la salud pública, la gestión ambiental y la participación comunitaria. El alineamiento con

estos marcos legales no solo fortalece la legitimidad del plan, sino que facilita la consecución de apoyo político, técnico y financiero por parte de las autoridades competentes.

Una integración efectiva implica que el plan sea consensuado con los actores clave, aprobado por las instancias correspondientes y socializado con la comunidad para fomentar la apropiación social de sus acciones. Así, el documento final no es solo una guía técnica, sino un compromiso colectivo que orienta la acción territorial hacia entornos más saludables y sostenibles.

Síntesis

El componente formativo aborda la planificación y ejecución de acciones orientadas a fortalecer la salud ambiental y la seguridad sanitaria, partiendo del conocimiento de la estructura y capacidades del sistema de salud pública, así como de la articulación institucional y la normativa vigente. Se exploran estrategias para la promoción de entornos saludables, incluyendo el diseño de iniciativas educativas comunitarias, la organización de campañas y la coordinación intersectorial, con énfasis en el cumplimiento de la legislación aplicable. Finalmente, se desarrolla el proceso de formulación de un plan de acción en salud ambiental y sanitaria, que contempla la definición de objetivos y metas, la identificación de actividades de manejo de riesgos, la asignación de responsables y recursos, la elaboración de un cronograma con mecanismos de seguimiento, y su integración considerando la valoración de riesgos, las capacidades locales y el marco normativo, garantizando así intervenciones coherentes, efectivas y sostenibles.



Material Complementario

Tema	Referencia	Tipo de material	Enlace del recurso
Estructura y capacidades del sistema de salud pública	Ecosistema de Recursos Educativos Digitales SENA. (2023). Enfermedades de interés en salud publica [Video]. YouTube.	Video	https://www.youtube.com/watch?v=171QM9JjtXA
Organización de campañas de salud ambiental	Ecosistema de Recursos Educativos Digitales SENA. (2023). Coordinar campaña ambiental según normativa vigente [Video]. YouTube.	Video	https://www.youtube.com/watch?v=NQL-u3FAp3w
Diseño del plan de acción en salud ambiental y sanitaria	Ecosistema de Recursos Educativos Digitales SENA. (2022). Plan de acción [Video]. YouTube.	Video	https://www.youtube.com/watch?v=eFJOKJMV sQs

Glosario

Articulación institucional: coordinación entre diferentes entidades y sectores para optimizar recursos, evitar duplicidades y fortalecer la capacidad de respuesta en salud pública y ambiental.

Capacidades locales: conjunto de recursos humanos, técnicos, financieros y logísticos disponibles en un territorio para responder eficazmente a necesidades y riesgos en salud pública.

Cronograma: herramienta de planificación que organiza las actividades de un plan de acción en el tiempo, indicando fechas, responsables y recursos necesarios.

Determinantes sociales de la salud: factores sociales, económicos y ambientales que influyen en la salud de la población y sus desigualdades.

Educación ambiental: proceso educativo participativo que busca sensibilizar, formar y movilizar a la comunidad para la protección del ambiente y la prevención de riesgos sanitarios.

Intersectorialidad: proceso educativo participativo que busca sensibilizar, formar y movilizar a la comunidad para la protección del ambiente y la prevención de riesgos sanitarios.

Meta: resultado concreto y medible que se espera alcanzar dentro de un periodo determinado, derivado de los objetivos de un plan de acción.

Objetivo: propósito general que orienta las acciones de un plan de salud ambiental y sanitaria, describiendo lo que se espera lograr.

Participación comunitaria: inclusión activa de la comunidad en la identificación de problemas, planificación y ejecución de acciones para mejorar la salud y el entorno.

Plan de acción: documento que organiza objetivos, actividades, responsables, recursos y cronogramas para abordar problemas de salud ambiental y sanitaria.

Riesgo ambiental: posibilidad de que factores del entorno, como contaminación o vectores, generen efectos adversos en la salud de la población.

Salud ambiental: disciplina que estudia y gestiona los factores del entorno que afectan la salud humana, promoviendo entornos saludables y sostenibles.

Seguridad sanitaria: conjunto de acciones y medidas para prevenir, controlar y mitigar riesgos que afecten la salud de la población.

Sistema Nacional Ambiental (SINA): conjunto de instituciones, normas y mecanismos en Colombia para la gestión, protección y control del ambiente.

Vigilancia epidemiológica: proceso sistemático de recolección, análisis e interpretación de información sobre la salud de la población para la toma de decisiones.

Referencias bibliográficas

ANLA. (2019). Informe de gestión ambiental por contingencia de hidrocarburos en Barrancabermeja. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Función Pública. (1991). Constitución Política de Colombia 1991.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125>

Función Pública. (2001). Ley 715 de 2001.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4452>

Función Pública. (2011). Ley 1438 de 2011.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41355#:~:text=E s%20obligaci%C3%B3n%20de%20la%20familia,su%20desarrollo%20arm%C3%B3nico%20e%20integral>

Función Pública. (2016). Decreto 780 de 2016 Sector Salud y Protección Social.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77813>

Instituto Nacional de Salud – INS. (2023). Boletín Epidemiológico Semanal.

Ministerio de Salud y Protección Social.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). Resolución 1229 de 2013:

Requisitos técnicos y sanitarios para actividades de inspección, vigilancia y control sanitario.

[https://www.minsalud.gov.co/Normatividad Nuevo/Resolución%201229%20de%202013.pdf](https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20Nuevo/Resolución%201229%20de%202013.pdf)

Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). Fortalecimiento de las capacidades territoriales en salud pública.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). Fortalecimiento de la gestión intersectorial en salud pública.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). Hogares sin mosquito, familias sin dengue. <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Hogares-sin-mosquito-familias-sin-dengue.aspx>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). Lineamientos para la implementación de Mesas Territoriales de Salud Ambiental.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2023). Informe de gestión 2023. <https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Documents/Informe-de-gestion-290124.pdf>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2023). Informe nacional de articulación institucional en salud pública.

Ministerio de Salud y Protección Social. (s. f.). Plan Decenal Salud Pública 2022-2031. <https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/PDSP-2022-2031.aspx>

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2021). Plan Departamental de Agua y Saneamiento.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2024). Basura cero. <https://www.minvivienda.gov.co/basura-cero>

Organización Panamericana de la Salud. (2023). La coordinación intersectorial como pilar de la salud pública.

Organización Panamericana de la Salud. (2024). Capacidades esenciales en los sistemas de salud de las Américas.

Organización Panamericana de la Salud. (s. f.). Semana de sensibilización sobre el mosquito.

República de Colombia. Congreso de la República. (1979). Ley 9 de 1979: Código Sanitario Nacional.

República de Colombia. Congreso de la República. (1993). Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental.

República de Colombia. Congreso de la República. (2015). Ley Estatutaria 1751 de 2015: Derecho fundamental a la salud.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Milady Tatiana Villamil Castellanos	Responsable Ecosistema de Recursos Educativos Digitales (RED)	Dirección General
Diana Rocío Possos Beltrán	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Christian Llano Villegas	Experto temático	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Viviana Esperanza Herrera Quiñonez	Evaluadora instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Oscar Ivan Uribe Ortiz	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Juan Daniel Polanco Muñoz	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Francisco José Vásquez Suárez	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Diego Fernando Velasco Güiza	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Ernesto Navarro Jaimes	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Eduardo Rueda Peña	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Bustos Gómez	Validador y vinculator de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima